UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

(Médecine génétique)
(Dépistage prénatal T21)
Sans patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Kairet Emma **Date de rédaction : 8/12/2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N°307 – Dépistage prénatal de la trisomie 21

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Stratégie diagnostique

Domaine de compétence n°2 (en sélectionner 1 SEUL) : Synthèse des résultats d'examens paracliniques

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1. Expliquer (à la patiente) les possibilités de prise en charge diagnostique selon le résultat du dépistage
2. Expliquer le déroulement d'un test de dépistage, son intérêt et ses limites, en vue de recueillir un consentement éclairé de la patiente

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- 1 table
- 1 chaise
- Compte rendu du dépistage

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Énonce que le cas se situe entre les bornes 1/51 et 1/1000 de risque	
Propose un dépistage prénatal non invasif (DPNI)	
Explique que le DPNI est le test ADNlc T21 et/ou prélèvement du sang maternel pour y rechercher l'ADN libre fœtal circulant	
Explique que le DPNI est non invasif	
Explique que le DPNI ne suffit pas au diagnostic	
Tache 2	
Explique que si DPNI positif, on propose un caryotype fœtal (CF)	
Explique que le CF, lui, permet le diagnostic	
Explique que le CF est un examen invasif	
Explique que le CF est un prélèvement de villosités choriales/de liquide amniotique ou de sang fœtal (en fonction du terme)	
Tache 3	
Explique que le consentement de la patiente est nécessaire	
Explique que le CF expose à des risques tels qu'une : infection du liquide amniotique, fausse couche, allo-immunisation foeto-maternelle, bradycardie si ponction de sang fœtal (*au moins 2/4*)	
Compétences génériques	
Aptitude à proposer une prise en charge (situations aigues/chroniques)	
Aptitude à planifier les soins	
Aptitude à fournir les renseignements (au patient / aux aidants)	

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Cocher si fait
Tache 1	
Énonce que le cas se situe entre les bornes 1/51 et 1/1000 de risque	1
Propose un dépistage prénatal non invasif (DPNI)	1
Explique que le DPNI est le test ADNlc T21 et/ou prélèvement du sang maternel pour y rechercher l'ADN libre fœtal circulant	1
Explique que le DPNI est non invasif	1
Explique que le DPNI ne suffit pas au diagnostic	1
Tache 2	
Explique que si DPNI positif, on propose un caryotype fœtal (CF)	1
Explique que le CF, lui, permet le diagnostic	1
Explique que le CF est un examen invasif	1
Explique que le CF est un prélèvement de villosités choriales/de liquide amniotique ou de sang fœtal (en fonction du terme)	1
Tache 3	
Explique que le consentement de la patiente est nécessaire	1
	1
Explique que le CF expose à des risques tels qu'une : infection du liquide amniotique, fausse couche, allo-immunisation foeto-maternelle, bradycardie si ponction de sang fœtal (*au moins 2/4*)	1
Compétences génériques	
Aptitude à proposer une prise en charge (situations aigues/chroniques)	
Aptitude à planifier les soins	
Aptitude à fournir les renseignements (au patient / aux aidants)	

Annexe références fiches LISA / Bibliographie

Grossesse normale – Item 23

Dépistage de la T21 OIC-023-08-A

Conduite à tenir en cas de dépistage de T21 positif OIC-023-09-B

Spécificités des maladies génétiques – Item 45

Connaître les modalités de réalisation d'un caryotype fœtal OIC-045-04-B
Connaître les modalités du dépistage anténatal de trisomie 21 OIC-045-05-A
Connaître les modalités du diagnostic anténatal de trisomie 21 OIC-045-06-B
Connaître les modalités de prescription d'un caryotype OIC-045-08-B